FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

PERFIL PRAGMÁTICO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS (TPP / TPP-ES)

Eje V: Neurodesarrollo y Lenguaje • Evaluación Pragmática Temprana de 6 a 48 Meses (Dewart & Summers; Botana & Peralbo, 2022)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Perfil Pragmático de Habilidades Comunicativas Cotidianas (Adaptación TPP-es).
Nombre Original	The Pragmatics Profile of Everyday Communication Skills (Dewart & Summers, 1995; NFER-Nelson).
Autores Originales	Hazel Dewart y Susie Summers (Reino Unido).
Adaptación Hispana	Iria Botana Lois y Manuel Peralbo Uzquiano (2020, 2022; Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurodesarrollo y Lenguaje. Uso funcional y social del lenguaje, intencionalidad e interacción.
Tipo de Instrumento	Cuestionario / entrevista estructurada dirigida a padres, cuidadores primarios o educadores.
Composición de Ejes	4 ejes evolutivos estructurados: Funciones, Respuesta, Interacción/Conversación y Contexto.
Población y Rango	Atención temprana y primera infancia (6 a 48 meses) y población infantil con necesidades de CAA.
Tiempo de Administración	20 a 30 minutos de entrevista clínica o cumplimentación guiada por el profesional.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico, educativo y de investigación en el ámbito logopédico.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: LA PRAGMÁTICA COMO EJE DEL DESARROLLO COMUNICATIVO

El **Perfil Pragmático (TPP)** constituye un hito fundamental en la evaluación del lenguaje infantil en contextos ecológicos:

1. **Más Allá de la Estructura Formal:** A diferencia de los tests de vocabulario receptivo o fonología que miden la forma o el contenido aislado, el TPP evalúa el **uso intencional y social** de la comunicación en rutinas diarias del hogar y la escuela.
2. **Detección Precoz de Trastornos del Neurodesarrollo:** Es especialmente sensible para captar los primeros signos del Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Trastorno de la Comunicación Social (Pragmático) y retrasos del desarrollo en niños pequeños antes de la escolarización obligatoria.
3. **Triangulación con la Familia:** Permite a logopedas y psicopedagogos registrar la intencionalidad comunicativa real mediada por gestos, miradas, vocalizaciones y palabras en interacción con sus cuidadores primarios.

3. ESTRUCTURA DE EJES Y DOMINIOS COMUNICATIVOS DEL TPP

Eje Evaluativo	Reactivos	Hitos Pragmáticos y Competencias Observables
1. Funciones Comunicativas	Hitos 6-48 m	Llamar la atención, pedir objetos/acciones, rechazar, saludar, mostrar afecto y pedir información.
2. Respuesta Comunicativa	Hitos 6-48 m	Reconocer que se le habla, responder a peticiones, interpretar la prosodia y gestos del adulto.
3. Interacción / Diálogo	Hitos 6-48 m	Atención conjunta, alternancia de turnos comunicativos, mantenimiento de temas y reparación.
4. Variación Contextual	Eje modular	Adaptación del estilo comunicativo a diferentes interlocutores (padres, extraños, pares) y lugares.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN EVOLUTIVA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y ESTRUCTURA FACTORIAL EN ESPAÑA

El estudio de validación psicométrica en España (Botana & Peralbo, 2022; $N = 185$ niños de 6 a 48 meses de edad) constató:

Propiedad Psicométrica	Coeficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Global	Alfa de Cronbach = 0.96	Fiabilidad psicométrica sobresaliente; homogeneidad excelente en la escala adaptada.
Estructura Factorial	Factor Unidimensional	Un único factor dominante explica el 61.3% de la varianza total de desarrollo pragmático.
Análisis Discriminante	Wilks' Lambda = 0.22	Capacidad altamente significativa ($p < 0.001$) para diferenciar con precisión los tramos etarios.
Sensibilidad Clasificatoria	Precisión = 88.6%	Clasificación correcta de niños según su grupo cronológico (6-12m, 12-18m, 18-24m, 24-36m, 36-48m).
Validez Concurrente	r = 0.79 con MacArthur-Bates	Elevada correlación con el Inventario de Desarrollo Comunicativo en edades tempranas.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN DEL PERFIL

• **Puntuación Directa por Hito:** Cada conducta o hito pragmático se codifica según su consolidación (0 = no manifiesta / ausente, 1 = emergente con apoyo, 2 = consolidado autónomamente).
• **Cálculo de la Puntuación Total TPP:** Sumatoria de los ítems de los tres ejes básicos:

$$\text{Puntuación Total TPP} = \sum \text{Ítems Funciones} + \sum \text{Ítems Respuesta} + \sum \text{Ítems Interacción}$$

• **Análisis Cualitativo del Perfil:** Además del cómputo numérico, se genera un diagrama de barras que visualiza la discrepancia entre las funciones expresivas y la comprensión pragmática en la interacción.

6. BAREMOS NORMATIVOS POR TRAMOS ETARIOS (BOTANA & PERALBO)

Tramo Etario	Media TPP	Desv. Típica	Hitos Críticos de Consolidación Pragmática Esperada
6 a 12 meses	18.4 pts	+/- 5.2 pts	Atención conjunta incipiente, sonrisa social, gestos de señalar y pedir con la mirada.
12 a 18 meses	34.7 pts	+/- 6.8 pts	Señalamiento protoimperativo y protodeclarativo consolidado; primeras palabras sociales.
18 a 24 meses	51.2 pts	+/- 7.4 pts	Uso del lenguaje para pedir y rechazar con claridad; juego interactivo simple.
24 a 36 meses	68.5 pts	+/- 8.1 pts	Mantenimiento de pequeños diálogos, formulación de preguntas y ajuste al oyente.
36 a 48 meses	82.1 pts	+/- 6.3 pts	Competencia conversacional amplia, narración de eventos y variación según contexto.

CRITERIO DE ALERTA DE RETRASO PRAGMÁTICO TEMPRANO:
Puntuaciones situadas a más de 1.5 desviaciones típicas por debajo de la media de su tramo etario (o ausencia de señalamiento protodeclarativo a los 18 meses) exigen valoración prioritaria en Atención Temprana para descartar TEA o Trastorno Pragmático de la Comunicación.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA: TEA VS. TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE

PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON EL TPP:

• **Paso 1 (Entrevista Inicial en Atención Temprana):** Administrar el TPP a los cuidadores ante quejas de retraso en la adquisición del habla o sospecha de dificultades socio-comunicativas.

• **Paso 2 (Análisis del Perfil Disociativo):**

• *Retraso en el habla con TPP en rango normal (contacto ocular, gestos deícticos y turnos conservados):* Perfil típico de **Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL)** de predominio fonológico/léxico; intención social indemne.

• *Colapso severo en el Eje de Interacción y Funciones (falta de atención conjunta, ausencia de sonrisa social e incapacidad para responder al nombre):* Fuerte sospecha de **Trastorno del Espectro Autista (TEA)**; aplicar inmediatamente M-CHAT-R/F o ADOS-2.

• *Uso del lenguaje solo instrumental (pedir cosas) sin compartir afecto ni intereses:* Trastorno de la Comunicación Social (Pragmático).

• **Paso 3 (Plan Logopédico y Familiar):** Indicar pautas de estimulación en rutinas diarias y valorar sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) si no hay intención verbal a los 24 meses.

8. CASO ILUSTRATIVO: SOSPECHA DE TEA EN NIÑO DE 26 MESES

Identificación: Niño de 26 meses, derivado por el pediatra de atención primaria a petición de los educadores de la escuela infantil, por ausencia de lenguaje verbal, escaso contacto visual y aparente sordera cuando se le llama por su nombre.

Evaluación con el Perfil Pragmático (TPP-es):

• **Puntuación Total TPP = 24 puntos** (Puntuación esperada para 24-36 meses: Media 68.5, $DT = 8.1$; rendimiento a > 4 desviaciones típicas bajo la media).

• *Desglose de Ejes:*

• Funciones Comunicativas: 10 pts (únicamente utiliza al adulto tomándole de la mano para alcanzar alimentos; no señala para mostrar objetos).

• Respuesta a la Comunicación: 6 pts (no gira ante su nombre en 9 de 10 ocasiones; no responde a requerimientos de atención del adulto).

• Interacción y Conversación: 8 pts (juego en solitario con alineación de juguetes; ausencia de alternancia de turnos).

Integración Diagnóstica: El TPP confirmó un colapso primario de la intencionalidad social y la reciprocidad pragmática, descartando un retraso simple del lenguaje.

Derivación: Confirmación diagnóstica con ADOS-2 (Módulo 1) y derivación inmediata al Equipo de Atención Temprana para intervención comunicativa intensiva centrada en la familia.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD, DEONTOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DESCARTAR HIPOACUSIA:
Antes de atribuir la falta de respuesta a un déficit pragmático o autismo, es imperativo realizar un despistaje audiológico formal (otoemisiones/PEATC).

VARIACIÓN CULTURAL:
Ciertas pautas de contacto visual y respeto al adulto varían según el contexto etnocultural; calibrar las respuestas de la familia con sensibilidad.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Botana Lois, I., & Peralbo Uzquiano, M. (2022). Adaptación al español y propiedades psicométricas de la escala The Pragmatics Profile. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, 42(1), 3-16. https://doi.org/10.1016/j.rlfa.2020.05.004
2. Dewart, H., & Summers, S. (1995). *The Pragmatics Profile of Everyday Communication Skills in Pre-School Children*. NFER-Nelson (Windsor).
3. Halliday, M. A. K. (1975). *Learning how to mean: Explorations in the development of language*. Edward Arnold (London).
4. Mogollón, M. E., & Portilla, O. M. (2015). Evaluación de la pragmática en niños: una revisión de metodologías disponibles. *Revista CEFAC*, 17(5), 1630-1641.